

GUIA DE ESTUDO — BANNER DE PNE

Manejo odontológico do paciente com TEA nível 3, TDAH e TAG

1. DE ONDE SAIU CADA PARTE DO RESUMO

Cada trecho do resumo está sustentado por uma das referências. É isso que você responde se a banca perguntar "de onde você tirou isso?".

"TEA nível 3 é o que exige maior suporte"

Classificação do DSM-5-TR por nível de suporte (1, 2 e 3). O nível 3 é descrito como "exigindo apoio muito substancial". Base conceitual, aparece também em BEZERRA et al. (2023).

"maior risco de cárie e doença periodontal"

DRUMOND et al. (2022) — metanálise em crianças com TDAH. BEZERRA et al. (2023) para o TEA.

"higiene depende do cuidador, dieta seletiva, psicofármacos reduzem o fluxo salivar"

BEZERRA et al. (2023) e a literatura nacional sobre TEA; a hipossalivação é efeito adverso conhecido de metilfenidato, risperidona e antidepressivos.

"anamnese detalhada com o responsável"

AAPD (2024) — a diretriz exige registrar histórico médico, temperamento, comportamento em atendimentos anteriores e técnicas já utilizadas antes de escolher o manejo.

"consultas curtas, mesmo horário, mesma sala, mesma equipe"

BEZERRA et al. (2023) e AAPD (2024): previsibilidade e redução de estímulos.

"dizer-mostrar-fazer e reforço positivo"

AAPD (2024) — as duas estão na lista de manejo básico (basic behavior guidance).

"dessensibilização"

AAPD (2024) e ALBHAISI et al. (2022): aproximação gradual e repetida do procedimento.

"pranchas e agendas de figuras" (pedagogia visual)

BALIAN et al. (2021) — revisão sistemática com metanálise; é a referência mais forte do resumo para esse ponto.

"vídeos que mostram o procedimento antes da consulta"

ALBHAISI et al. (2022) — video modeling entre as técnicas psicológicas revisadas.

"diminuir luz, ruído e odores"

CERMAK et al. (2015) e STEIN DUKER et al. (2023) — ambiente sensorialmente adaptado.

"contenção protetora, sedação e anestesia geral reservadas"

AAPD (2024) — são classificadas como manejo avançado, usadas quando o básico não basta e sempre com consentimento informado.

"não existe um protocolo único"

ALBHAISI et al. (2022) — a própria revisão conclui que a evidência ainda é inconclusiva e heterogênea, o que impede um protocolo universal.

2. RESUMO DAS REFERÊNCIAS

AAPD (2024) — Behavior guidance for the pediatric dental patient

Reference Manual of Pediatric Dentistry, p. 358-378. Diretriz da Academia Americana de Odontopediatria, revisada periodicamente.

- O que é: não é pesquisa, é diretriz. Serve para justificar conduta.
- Divide o manejo em básico e avançado. Básico: comunicação, imagens positivas antes da consulta, observação de outro paciente, dizer-mostrar-fazer, perguntar-dizer-perguntar, controle de voz, comunicação não verbal, reforço positivo, distração e dessensibilização.
- Avançado: contenção protetora, sedação e anestesia geral.
- Manda documentar histórico médico, temperamento, consentimento informado com riscos e alternativas, avaliação de dor, urgência do tratamento e comportamento em consultas anteriores.
- Sobre contenção: usar apenas quando necessário para proteger a criança e a equipe, e sempre a técnica menos restritiva possível (há uma diretriz específica só sobre isso).
- Por que usei: sustenta quase toda a parte de conduta do resumo.

BALIAN et al. (2021) — Pedagogia visual

Int J Environ Res Public Health, v. 18, n. 2, p. 789. Revisão sistemática com metanálise.

- Pergunta: a pedagogia visual melhora a cooperação e a higiene bucal em crianças com TEA?
- Pedagogia visual = pranchas, sequências de figuras, agenda visual, histórias sociais, cartões que mostram cada etapa do que vai acontecer.
- Resultado: melhora as habilidades de escovação e a higiene bucal, e aumenta o nível de cooperação durante o atendimento. Material visual adaptado culturalmente reduziu a ansiedade em comparação ao grupo controle.
- Por que usei: é a evidência mais forte a favor das pranchas e agendas de figuras.

ALBHAISI et al. (2022) — Técnicas psicológicas

BMC Oral Health, v. 22. Revisão sistemática de literatura.

- Revisa as técnicas não farmacológicas usadas com crianças com TEA: dizer-mostrar-fazer, dessensibilização, modelagem por vídeo, reforço positivo, suportes visuais.
- Resultado: os estudos mostram efeitos favoráveis, mas a evidência é considerada inconclusiva quanto à força, por causa da heterogeneidade metodológica e das amostras pequenas.
- Por que usei: sustenta a frase da conclusão sobre não existir protocolo único. É um ponto honesto do trabalho, e a banca costuma gostar quando o aluno reconhece a limitação.

CERMAK et al. (2015) — Ambiente sensorialmente adaptado (estudo piloto)

J Autism Dev Disord, v. 45, n. 9, p. 2876-2888. Ensaio clínico randomizado piloto.

- 44 crianças de 6 a 12 anos: 22 com TEA e 22 com desenvolvimento típico.
- Cada criança passou por duas profilaxias, uma em ambiente convencional e outra em ambiente adaptado, em ordem sorteada, com 3 a 4 meses de intervalo.

- Adaptações: luz reduzida, projeção em movimento no teto (peixes, bolhas), música calma e colete com peso que envolve a criança.
- Resultado: menos estresse, menos desconforto sensorial e menor percepção de dor no ambiente adaptado.
- Por que usei: é a origem do conceito de adaptação sensorial do consultório.

STEIN DUKER et al. (2023) — Ambiente sensorialmente adaptado (estudo grande)

JAMA Network Open, v. 6, n. 6, e2316346. Ensaio clínico randomizado cruzado.

- É a continuação do estudo do Cermak, agora com 162 crianças autistas.
- Resultado: estresse fisiológico significativamente menor no ambiente adaptado em todas as fases da consulta, indicando menor ativação simpática, ou seja, a criança mais relaxada.
- Também reduziu o sofrimento comportamental, e o método foi considerado seguro.
- Por que usei: é a evidência de melhor qualidade do resumo. Se a banca perguntar qual o estudo mais forte que você citou, é este.

DRUMOND et al. (2022) — Cárie e TDAH

Caries Research, v. 56, n. 1, p. 3-14. Revisão sistemática com metanálise.

- Compara a ocorrência de cárie em crianças com TDAH e sem TDAH.
- Resultado: crianças com TDAH têm mais chance de apresentar cárie (OR = 3,31; IC 95% 1,25-8,73).
- Explicações apontadas: dificuldade de manter rotina de higiene, falta de motivação, maior acúmulo de biofilme, sangramento gengival e consumo de alimentos cariogênicos por impulsividade.
- Por que usei: sustenta a frase sobre maior risco de cárie, na parte do TDAH.

BEZERRA; ASSIS; SANTOS (2023) — Atendimento odontológico de crianças com TEA

Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 3, p. 13155-13171. Revisão de literatura, em português e com acesso livre.

- Revisão nacional sobre as características das crianças com TEA e as estratégias de atendimento.
- Aborda as alterações bucais mais comuns, a dificuldade de higiene, a importância do cuidador e as técnicas de manejo.
- Por que usei: é a referência em português, a mais fácil de ler inteira e a melhor para você estudar primeiro. Leia esta antes das outras.

3. O QUE ESTUDAR ALÉM DAS REFERÊNCIAS

- DSM-5-TR: os três níveis de suporte do TEA e o que muda entre eles. Você precisa saber explicar por que o nível 3 é o mais grave.
- TDAH: os três tipos (desatento, hiperativo-impulsivo e combinado) e os medicamentos mais usados (metilfenidato, lisdexanfetamina) com seus efeitos na boca.
- TAG: como a ansiedade aparece na criança (irritabilidade, queixas físicas, recusa) e por que ela piora a aceitação do atendimento.
- Medicamentos e boca seca: metilfenidato, risperidona, aripiprazol e antidepressivos. Saiba dizer qual o efeito bucal de cada um.
- Seletividade alimentar no TEA: por que a dieta costuma ser pastosa, doce e repetitiva.
- Bruxismo, automutilação e traumatismo dentário nesses pacientes.
- TEACCH e PECS: são os dois métodos de comunicação estruturada citados na literatura de TEA. Vale saber o que cada sigla significa.
- Lei 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, que garante à pessoa com autismo os mesmos direitos da pessoa com deficiência) e Lei 13.977/2020, a Lei Romeo Mion, que criou a carteira de identificação (CIPTA).
- Prevalência: dados do CDC de 2025 (ano de vigilância 2022) apontam 1 em cada 31 crianças de 8 anos identificadas com TEA nos EUA, contra 1 em 36 no levantamento anterior. Bom número de abertura para a apresentação.
- Prevenção: verniz fluoretado, selantes, escovação supervisionada pelo cuidador e ART. É o que você vai defender como prioridade.

4. PERGUNTAS QUE PODEM TE FAZER

Por que não sedar logo, já que a paciente não colabora?

Porque a AAPD coloca sedação e anestesia geral como manejo avançado, indicado quando o básico falha. Além do risco e do custo, a sedação resolve a consulta, mas não ensina a criança a aceitar o atendimento. O condicionamento tem efeito duradouro.

Qual a diferença entre contenção protetora e imobilização?

Contenção protetora é a estabilização, com consentimento e registro em prontuário, na técnica menos restritiva que permita atender com segurança. Imobilização sem consentimento e sem indicação é conduta inadequada.

A pedagogia visual funciona mesmo ou é só teoria?

Funciona: a metanálise do Balian mostra melhora da cooperação e da higiene bucal. A limitação é que os estudos são pequenos e heterogêneos.

Por que a criança com TEA tem mais cárie?

Não é a condição em si. É a soma de higiene dependente do cuidador, dieta seletiva e cariogênica, boca seca por medicamento e dificuldade de escovar por hipersensibilidade na boca.

O que você faria se nada disso funcionasse?

Manteria a adequação do meio bucal e o controle preventivo, escalaria para sedação ou anestesia geral conforme a necessidade e a urgência do tratamento, sempre com consentimento e em conjunto com a família e o médico que acompanha a criança.

5. ONDE LER CADA UMA

- BEZERRA et al. (2023): ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/60794
- AAPD (2024): aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/bp_behavguide.pdf
- AAPD, contenção protetora: aapd.org/media/Policies_Guidelines/BP_Protective.pdf
- BALIAN et al. (2021): ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7832292
- ALBHAISI et al. (2022): bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-022-02200-7
- CERMAK et al. (2015): pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25931290
- STEIN DUKER et al. (2023): ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10238943
- DRUMOND et al. (2022): karger.com/cre/article/56/1/3